

30 - 01-Sémiologie cardiovasculaire Introduction - Pr. L. Bendriss

(0:07 - 0:44)

Bonjour, on va essayer de traiter aujourd'hui la sémiologie qui serait dédiée à l'appareil cardiovasculaire. Alors, c'est quoi la sémiologie? La sémiologie médicale est une branche qui a pour but de recenser ou de réunir le maximum de signes, ou ce qu'on appelle le symptôme, en vue d'avoir un diagnostic, c'est-à-dire connaître un petit peu la maladie à travers tous ces signes. Alors, les signes peuvent être recueillis de deux manières.

(0:45 - 1:14)

Déjà à l'étape clinique, vous avez l'interrogatoire, c'est-à-dire qu'on va essayer d'interroger le patient avec des questions et réponses pour essayer d'avoir le maximum de renseignements et des choses dont il en souffre. Et puis, par la suite, on va passer à l'étape suivante qui est l'examen clinique. Au cours de l'examen clinique, on va essayer d'examiner le patient aussi bien sur le plan général, la crise des constantes, c'est-à-dire la tension artérielle, la température, la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire.

(1:15 - 1:41)

Et puis, passer appareil par appareil pour essayer de recenser le maximum de signes à travers cet examen clinique. Alors, les signes que vous allez recueillir par ces deux modalités, à savoir l'interrogatoire et l'examen clinique, on les appelle étapes cliniques. Si l'étape clinique n'est pas suffisante pour pouvoir reconnaître le diagnostic, on passe à l'étape suivante qui est l'étape paraclinique.

(1:41 - 2:19)

Dans l'étape paraclinique, vous aurez à faire soit à l'imagerie médicale tout ce qui va concerner la radiologie et à la biologie tout ce qui va concerner les analyses aussi bien sanguines, urinaires ou autres, pour pouvoir avoir des informations supplémentaires qui peuvent nous approcher lors de cette étape pour avoir un diagnostic. Alors, toutes ces informations vont être regroupées sous forme d'un recueil pour pouvoir poser le diagnostic de la maladie. Finalement, la sémiologie est une discipline qui va étudier les signes qu'on avait précédemment cités.

(2:20 - 2:45)

Ces signes peuvent être soit fonctionnels quand on va les recueillir à l'interrogatoire, c'est-à-dire quand on va poser des questions-réponses, soit physiques, c'est-à-dire à l'étape de l'examen clinique quand on va examiner notre patient. Quand on parle de signes fonctionnels, c'est au cours de l'interrogatoire et quand on parle de signes physiques, c'est au cours de l'examen clinique. Ceci pour vous dire quoi? Il ne faut pas mélanger ces terminologies.

(2:45 - 3:24)

Quand on vous pose une question à l'examen, quels sont les signes fonctionnels d'une telle maladie? Automatiquement, vous allez vous référer à tout ce qui est interrogatoire et vous oubliez l'examen clinique. Alors, les objectifs de la sémiologie, c'est d'essayer d'abord, avant d'interroger les patients, de poser des questions-réponses par rapport à une souffrance particulière. Pas n'importe qui fait n'importe quoi, c'est-à-dire pas n'importe patient va faire une maladie X. Il devrait y avoir des circonstances qui vont favoriser cette pathologie.

(3:24 - 4:13)

C'est ce qu'on appelle les antécédents, que ce soit personnels ou familiaux, et puis des facteurs de risque qui prédisposent à une certaine maladie. Alors, par rapport à la cardiologie, nous avons ce qu'on appelle des facteurs de risque, par exemple cardiovasculaires athéromateux, notamment le diabète, l'hypertension artérielle, la dyslipidémie, qui vont nous prédisposer à avoir une plaque d'athérone qui va être pourvoyeuse des complications cardiovasculaires telles que les infarctus du myocarde, les accidents vasculaires cérébraux ischémiques et les artériopathies oblitérantes des membres inférieurs. Après avoir connu un petit peu ces circonstances favorissantes, nous allons passer à l'étape question-réponse pour essayer de rechercher un petit peu, à partir de ce signe fonctionnel que va vous rapporter le patient, un petit peu son origine cardiovasculaire.

(4:13 - 4:31)

En cardiologie, nous avons quatre signes cardinaux qui sont la dyspnée, la douleur thoracique, les palpitations et les pertes de connaissances. Alors, je prends l'exemple d'une dyspnée. Donc la dyspnée, par exemple, elle pourrait être grossièrement d'origine respiratoire ou cardiaque.

(4:32 - 4:49)

Le but de l'interrogatoire, c'est d'essayer de caractériser cette dyspnée pour pouvoir dire que c'est plutôt d'origine cardiovasculaire que respiratoire. Je vous donne un exemple. Par exemple, quelqu'un qui vous dit que je fais une dyspnée à la montée des étages, c'est plus en faveur d'une origine cardiaque.

(4:49 - 5:14)

Et quelqu'un qui vous dit que je fais une dyspnée saisonnière, c'est plus en faveur d'une origine respiratoire. Ceci est un simple exemple pour vous dire que plus vous décrivez votre signe cardinal, plus vous approchez l'origine de ce signe. Donc par la suite, après l'étape interrogatoire, on va passer à l'examen clinique, donc de manière globale et cardiovasculaire en particulier.

(5:15 - 5:26)

Et dans cet examen clinique, je vous ai dit en rapport ce qu'on appelle les signes physiques. Donc on va essayer de chercher s'il y a une dilatation des cavités cardiaques. Tout ceci, on va le savoir à travers la sémiologie, notamment le ventricule gauche.

(5:26 - 5:49)

Si vous avez une sténose valvulaire ou une fuite valvulaire à travers des souffles qu'on voit à l'examen clinique. Une atteinte péricardique, vous avez un épanchement péricardique, une hypertension artérielle pulmonaire et les signes physiques d'une insuffisance cardiaque. Alors la première étape, quand on voit un patient, on va essayer de rédiger une observation clinique.

(5:49 - 6:22)

Donc cette observation va comporter en premier temps ce qu'on appelle l'interrogatoire. Dans cet interrogatoire, on va parler d'abord, on va essayer de connaître l'identité du patient, son motif de consultation à travers les signes cardinaux dont je vous ai parlé, à savoir la dyspnée, la douleur thoracique, les pertes de connaissances. Puis essayer d'étudier ce qu'on avait dit tout à l'heure, les antécédents et les facteurs de risque cardiovasculaires pour chercher si le patient a des circonstances favorisant pour une telle pathologie ou autre.

(6:22 - 6:35)

Puis les signes fonctionnels qu'on va décrire de manière très sémiologique. Après avoir fini l'interrogatoire, on va passer à l'examen physique. Donc l'examen physique va comporter de manière très méthodique l'examen général de manière globale.

(6:36 - 7:00)

La mesure de la pression artérielle au niveau des deux bras en position couchée, en position debout. L'examen cardiaque avec toutes les étapes de l'examen, à savoir l'inspection, palpation, percussion, auscultation. N'oublions pas l'examen vasculaire et puis on finit toujours par l'examen des autres appareils parce qu'un malade c'est un tout, c'est une finalité et non pas un seul appareil.

(7:01 - 7:56)

Alors les signes fonctionnels ou les motifs de consultation en cardiologie, et c'est essentiellement les quatre dont je vous ai parlé, la dyspnée, c'est-à-dire le gêne respiratoire, la douleur thoracique, syncope ou hypothermie qui sont des pertes de connaissances et les palpitations, c'est une sensation d'accélération du rythme cardiaque. Alors les signes physiques, c'est-à-dire à l'étape de l'examen clinique, vous avez l'examen général de manière globale avec la prise des constantes, la mesure de la pression artérielle qui est capitale en cardiologie, l'examen cardiaque, l'examen vasculaire et on finit par l'examen des autres appareils. Alors pour l'examen

cardiaque spécialement, donc on saute généralement la percussion, vous avez uniquement l'inspection, la palpation et on se base beaucoup sur l'auscultation pour poser dans la plupart des cas le diagnostic d'une pathologie X ou Y. Je vous remercie.